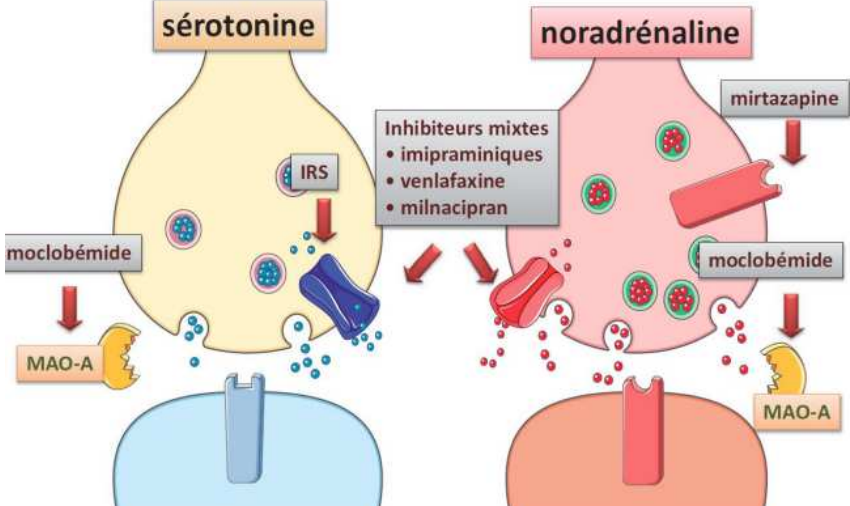


Toxicologie des IRS, IRSN, IMAO et autres antidépresseurs

Antidépresseurs	• Principale hypothèse physiopathologie de la dépression = déficit de transmission de 3 monoamines : – ↘ 5-HT – ↘ NA – ↘ DOPA – Plasticité neuronale aussi altérée en réponse au stress et aux déficits monoaminergiques • Tous les antidépresseurs sont indiqués dans le ttt des épisodes dépressifs majeurs + certains ont aussi des indications pour les troubles anxieux • Plusieurs classes médicamenteuses : – Antidépresseurs imipraminiques = tricycliques (déjà traités) : apparus les premiers, AD historiques de référence – IMAO-A : désormais peu utilisés – IRS – IRSN = les 2 classes les plus utilisées ajd – Autres antidépresseurs • Fréquence élevée d'intoxications : – Levée d'inhibition produite par le ttt favorisant le geste suicidaire – Pouvoir toxique – Marge thérapeutique étroite pour certains
Mécanisme d'action	 The diagram illustrates the mechanism of action of various antidepressants on the serotonin (sérotonine) and norepinephrine (noradrénaline) pathways. It shows two presynaptic terminals: a yellow one for serotonin and a pink one for norepinephrine. Inside these terminals are vesicles containing neurotransmitters. Arrows indicate the release of these neurotransmitters into the synaptic cleft. Below the terminals are receptors (blue for serotonin, red for norepinephrine). The diagram also shows the degradation of neurotransmitters by MAO-A (monoamine oxidase A) and the inhibition of this process by moclobémide. A central box lists 'Inhibiteurs mixtes' (mixed inhibitors) including imipraminiques, venlafaxine, and milnacipran, which block the reuptake of both neurotransmitters. Mirtazapine is shown blocking the reuptake of norepinephrine. • Pour traiter un épisode dépressif, l'approche pharmacologique repose essentiellement sur l'augmentation des transmissions sérotoninergiques et noradrénergique • La stimulation des transmissions à lieu au niveau pré-synaptique en bloquant les systèmes de recapture respectifs (pour les IRS et IRSN) • Le moclobémide inhibe la dégradation de la sérotonine et de la NA en métabolites inactifs en bloquant la monoamine oxydase A (MAO-A) • La mirtazapine, appartenant au groupe des autres AD, entraîne le blocage des récepteurs pré-synaptiques noradrénergiques

	• Charbon activé si < 2h pour décontamination digestive, qq soit l'AD en cause • Symptomatique : – Coma = intubation + ventilation assistée – Convulsions = diazépam (10 à 20mg) ou clonazépam (1mg) IV – Trismus invalidant = curarisation • Réhydratation • Surveillance ECG • Faible intérêt de l'analyse toxicologique car corrélation entre les concentrations plasmatiques et les manifestations cliniques pas clairement établie
CQFR	• Les intoxications par IRS ou IRSN sont fréquentes du fait de l'augmentation des prescriptions de ces mds • Souvent poly-intoxication massive à but suicidaire • Généralement peu symptomatique même pour des doses supposées ingérées importantes • Evolution favorable en 24h • En cas d'association entre eux ou avec d'autres toxiques : Peut favoriser la survenue d'un sd sérotoninergique = complication redoutée, parfois mortelle • Prise en charge : – +/- Charbon activé – Essentiellement symptomatique – En milieu hospitalier

